

SCA · dor torácica e conduta inicial

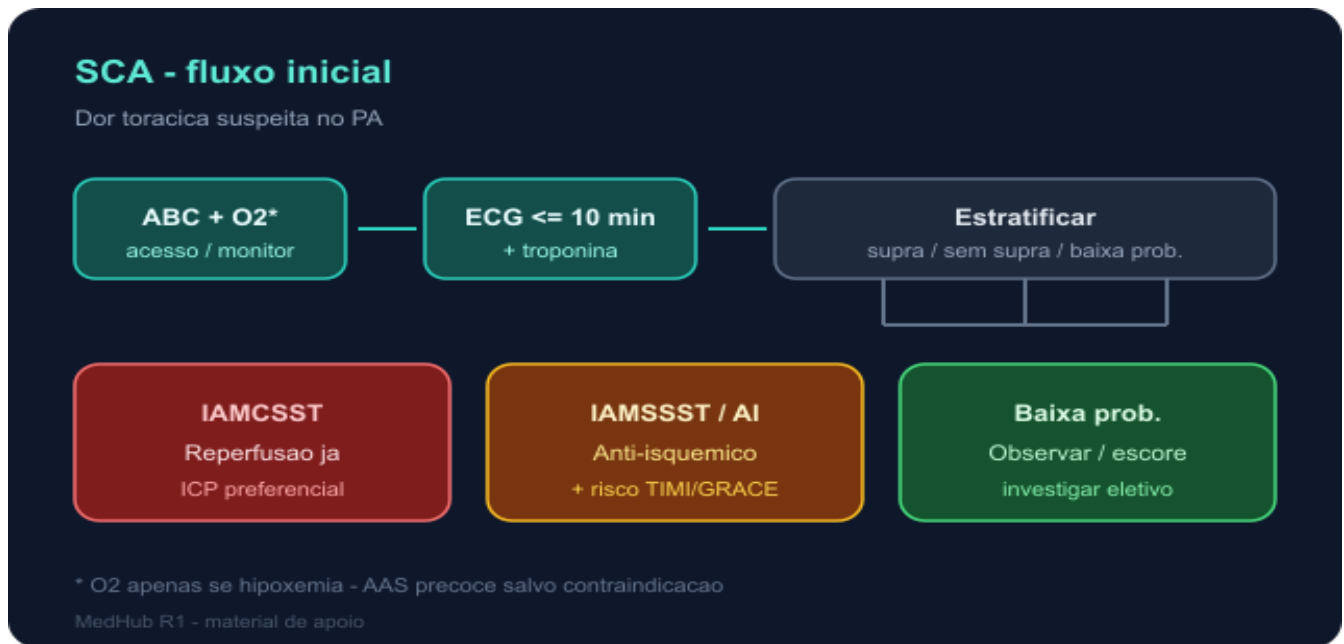
Na prova, a sequência importa: ABC !' ECG rápido !' estratificar !' anti-isquêmicos e decisão de reperfusão.

Pegue o ECG cedo

Lembre - Pegue o ECG cedo

ECG em até 10 minutos na chegada com dor torácica suspeita. Comparar com ECG prévio quando houver.

Fluxo resumido da SCA no pronto atendimento.



Suspeita alta — o que não esquecer

- Dor/opressão retroesternal, irradiação, náusea, sudorese, dispneia
- Equivalente angioso em idosos, diabéticos e mulheres (dispneia, epigastralgia, fadiga)
- Fatores: tabagismo, DM, HAS, dislipidemia, história familiar, DRC

Estratificação prática

Cenário | Achado-chave | Conduta-chave

IAMCSST | Supra de ST / equivalente | Reperusão imediata (ICP preferencial)

IAMSSST / AI | Troponina $\pm$ infra / T invertido | Anti-isquêmico + risco (TIMI/GRACE)

Baixa probabilidade | ECG e troponina negativos | Observação / escore / investigação eletiva

Medidas iniciais (salvo contraindicação)

- AAS 150–300 mg mastigado (dose de ataque)
- Anticoagulação conforme protocolo (enoxaparina/heparina)
- Inibidor P2Y12 conforme estratégia de reperfusão
- Nitrato se dor e PA adequada; morfina se dor refratária
- Oxigênio só se hipoxemia (não rotina em SpO₂ normal)

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Nitrato é contraindicado com uso recente de inibidor de PDE-5 e na suspeita de IAM de ventrículo direito (infra em DII/DIII/aVF com pré-carga dependente).

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Escores e critérios de SCA orientam estratificação, decisão de reperfusão e terapia anti-isquêmica nas provas de R1.

Quanto maior o TIMI, maior risco de eventos e benefício de estratégia invasiva precoce.

TIMI UA/NSTEMI (7 itens)

1 ponto cada; risco 0-7

Idade ≥ 65 anos	1
≥ 3 FRs coronarianos	1
Estenose coronária conhecida $\geq 50\%$	1
AAS nos últimos 7 dias	1
Angina severa recente (≥ 2 episódios/24h)	1
Desvio ST $\geq 0,5$ mm	1
Troponina/CK-MB elevada	1

0-2 baixo | 3-4 intermediário | 5-7 alto

Novo supra em ≥ 2 derivações contíguas (ou BRE novo/equivalente) + contexto clínico = ativar reperfusão.

Critérios de supra (STEMI)

ECG - elevação de ST

- 1 Dor torácica / equivalente isquêmico
- 2 Supra ST em ≥ 2 derivações contíguas
- 3 Ou BRE novo / equivalente de supra
- 4 Tempo até PCI ou fibrinólise

Homens: V2-V3 ≥ 2 mm (ou $\geq 2,5$ mm $<40a$); mulheres V2-V3 $\geq 1,5$ mm; demais ≥ 1 mm

Preditor clássico de mortalidade no IAM.

Killip (ICC na SCA)

Classe clínica a beira-leito

I - sem sinais de IC	I
II - estertores / B3 / congestão	II
III - edema agudo de pulmão	III
IV - choque cardiogênico	IV

I sem IC | II congestão leve | III edema agudo | IV choque

GRACE (ideia de prova)

Lembre - GRACE (ideia de prova)

GRACE estima mortalidade hospitalar/6 meses com idade, FC, PAS, creatinina, Killip, PCR cardíaca, desvio ST e troponina elevada. TIMI é mais memorizável; GRACE é o mais robusto.

Mnemônico anti-isquêmico (MONA-BASH / ABC)

- AAS 162–325 mg mastigado + P2Y12 (clopi/ticagrelor/prasugrel conforme cenário)
- Anticoagulação (enoxaparina/heparina/fondaparinux conforme protocolo)
- Betabloqueador se sem contraindicação (choque, BAV, broncoespasmo grave)
- Estatina alta intensidade + IECA/BRA (especialmente FEI, DM, IAM anterior)
- Nitrato/morfina só se dor/congestão — cuidado em IAM inferior/DVD e hipotensão
- O2 se SpO2 < 90–94% (não oxigenar rotineiramente se normoxêmico)

Reperusão no supra

Meta | Tempo

Porta-balão (PCI primária) | "d 90 min (ideal)

Fibrinólise se PCI > 120 min | "d 30 min porta-agulha

Janela fibrinólise típica | até 12 h do início dos sintomas

Armadilha

Atenção - Armadilha

IAM inferior + hipotensão: pense em DVD / extensão VD — evite nitratos e volume criterioso.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1